

GOBIERNO DE PUERTO RICO

20^{ma.} Asamblea
Legislativa

2^{da.} Sesión
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

P. del S. 858

17 de noviembre de 2025

Presentado por señor *Ríos Santiago*

Referido a la Comisión de Salud

LEY

Para enmendar el Artículo 1.02, añadir nuevos incisos (k-1), (u-1), (u-2), (aa-1), (dd-1), (dd-2) y (nn-1) al Artículo 1.03, añadir un nuevo inciso (f) al Artículo 5.04, añadir un nuevo Artículo 5.11-A, enmendar el Artículo 5.16 y añadir un nuevo Artículo 5.18 de la Ley 247-2004, según enmendada, conocida como “Ley de Farmacia de Puerto Rico”, a los fines de establecer un marco regulatorio para los medicamentos compuestos de alto riesgo y las farmacias no residentes que permita la responsable protección salubrista de los pacientes localizados en Puerto Rico; sin imponer requisitos duplicativos a farmacias físicamente localizadas en la jurisdicción de Puerto Rico, debidamente licenciadas bajo la Ley 247-2004; requerir la publicación de informes bianuales por parte de la Secretaría Auxiliar para la Regulación de la Salud Pública (SARPS) junto con la Oficina de Planificación y Desarrollo sobre la supervisión de las prácticas de preparación de medicamentos compuestos; garantizar una mayor visibilidad sobre las acciones regulatorias para proteger a los pacientes de medicamentos preparados ilegalmente; y para otros fines relacionados.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La preparación ilegal de medicamentos compuestos representa un desafío creciente y de gran magnitud en Puerto Rico, que pone en riesgo la seguridad de los pacientes y la integridad del sistema de salud. Los ciudadanos merecen medicamentos en los que puedan confiar, que sean seguros, efectivos y elaborados conforme a los más altos estándares de calidad establecidos por las regulaciones estatales y federales. Sin

embargo, en los últimos años, se ha observado un aumento alarmante en la distribución de medicamentos compuestos sin la supervisión adecuada, lo que constituye una amenaza significativa para la salud pública. Este problema es particularmente pronunciado en el caso de los medicamentos GLP-1 utilizados para el tratamiento de la diabetes y la obesidad, aunque se extiende a otras clases de medicamentos, afectando a diversos sectores de la población.

La preparación de medicamentos compuestos, cuando se realiza conforme a las normativas, es una práctica esencial que permite adaptar tratamientos a las necesidades específicas de los pacientes. No obstante, la proliferación de actividades de preparación ilegal, especialmente en entornos no regulados como spas médicos y clínicas de bienestar, ha evidenciado un vacío regulatorio que trasciende la mera supervisión del establecimiento físico o del profesional que realiza el procedimiento. El problema salubrista no radica únicamente en la práctica estética, sino en el manejo y administración de medicamentos compuestos cuya naturaleza requiere controles y supervisión especializada. Cuando estos productos son preparados sin receta individual previa, adquiridos como ingredientes farmacéuticos activos sin adecuada trazabilidad, o prescritos mediante evaluaciones insuficientes, se desdibuja la línea entre la composición farmacéutica legítima y la manufactura no regulada. Ello coloca al paciente en una posición de vulnerabilidad y dificulta la intervención temprana del Estado ante eventos adversos o prácticas negligentes. Estos establecimientos, que a menudo operan sin la fiscalización de la Secretaría Auxiliar para la Regulación de la Salud Pública (en adelante, SARPS) y la Junta Examinadora de Farmacia en materia de medicamentos, representan puntos ciegos regulatorios. Los actores malintencionados aprovechan estas lagunas legales y de cumplimiento para producir y comercializar medicamentos no aprobados a una escala sin precedentes, exponiendo a los pacientes a riesgos graves, como la administración de productos ineficaces, contaminados o potencialmente peligrosos.

A esta realidad se suma el aumento en la dispensación y envío de medicamentos compuestos hacia Puerto Rico por parte de farmacias ubicadas fuera de la jurisdicción,

comúnmente denominadas farmacias no residentes. Si bien estas entidades pueden estar autorizadas en sus estados de origen, su operación hacia pacientes en Puerto Rico plantea retos particulares de fiscalización, acceso a información regulatoria y capacidad de respuesta ante eventos adversos o incumplimientos. La ausencia histórica de un mecanismo uniforme de registro y supervisión local ha limitado la visibilidad de las autoridades regulatorias sobre el volumen, naturaleza y riesgos asociados a medicamentos compuestos que ingresan a la jurisdicción desde el exterior, especialmente aquellos clasificados como de alto riesgo.

A lo anterior, se añade la limitada disponibilidad de información pública sobre las acciones de fiscalización que realizan las entidades reguladoras para atender esta problemática. Actualmente, no existe un mecanismo sistemático de recopilación y divulgación que permita conocer, entre otros aspectos, el número de farmacias no residentes que preparan o dispensan medicamentos compuestos para pacientes localizados en Puerto Rico, las inspecciones efectuadas, la naturaleza de las violaciones detectadas, las investigaciones iniciadas ni las medidas correctivas o disciplinarias impuestas. Esta insuficiencia de datos dificulta la evaluación objetiva de la efectividad del marco regulatorio vigente y limita la capacidad del Estado para asignar recursos y diseñar estrategias basadas en evidencia que fortalezcan la protección de los pacientes.

Por todo lo cual, resulta imperativo enmendar la “Ley de Farmacia de Puerto Rico” para establecer un marco legal abarcador que regule y supervise específicamente los medicamentos compuestos de alto riesgo, independientemente del entorno en que se administren. Una legislación integral debe definir con claridad estos medicamentos, imponer requisitos de receta individualizada, asegurar la trazabilidad de los ingredientes activos, exigir notificación de eventos adversos y facultar a las autoridades sanitarias para fiscalizar su preparación y dispensación. Solo mediante un régimen normativo coherente y robusto podrá el Estado cumplir con su deber indelegable de proteger la salud pública, garantizar la seguridad del paciente y prevenir que prácticas comerciales emergentes comprometan estándares básicos de calidad y responsabilidad sanitaria.

Ante este escenario, esta Ley enmienda la “Ley de Farmacias de Puerto Rico” para establecer un marco robusto de transparencia, registro y rendición de cuentas en la supervisión de la preparación y dispensación de medicamentos compuestos, particularmente aquellos clasificados como de alto riesgo. Como componente esencial, se dispone el requisito de registro de farmacias no residentes que envíen, dispensen o distribuyan medicamentos compuestos a pacientes en Puerto Rico, con el propósito de permitir a las autoridades regulatorias identificar, evaluar y supervisar de manera más efectiva estas operaciones extraterritoriales con impacto directo en la salud pública local. Dicho registro facilitará el acceso a información sobre licencias vigentes, historial disciplinario, cumplimiento con estándares federales aplicables y volumen de operaciones hacia la jurisdicción, fortaleciendo la capacidad de vigilancia y respuesta regulatoria.

Mediante la implementación de requisitos de informes periódicos, se proveerá a la Asamblea Legislativa, a las entidades reguladoras y al público información clara y estandarizada sobre las actividades de licenciamiento, registro, inspección, investigación y disciplina relacionadas con establecimientos no residentes que manejen medicamentos compuestos. Estos informes permitirán identificar tendencias, riesgos emergentes y necesidades de recursos humanos y materiales, fortaleciendo la capacidad institucional de fiscalización.

En última instancia, esta legislación tiene como objetivo fortalecer la protección de los pacientes puertorriqueños, asegurando que los medicamentos que reciben sean seguros, efectivos y elaborados bajo estrictos estándares de calidad. Al promover una supervisión más efectiva, coordinada y transparente entre la Secretaría Auxiliar para la Regulación de la Salud Pública (SARSP), incluyendo supervisión de farmacias no residentes, esta Ley constituye un paso esencial para mitigar los riesgos asociados a la preparación ilegal de medicamentos y para preservar la confianza pública en el sistema de salud.

La Asamblea Legislativa reconoce que las farmacias localizadas físicamente en Puerto Rico, debidamente licenciadas, que realizan composición farmacéutica, incluyendo farmacias 503A, ya se encuentran sujetas a licenciamiento, inspección y fiscalización directa bajo la Ley 247-2004, los reglamentos promulgados por el Departamento de Salud, la Junta Examinadora de Farmacia, leyes y reglamentos federales y los estándares USP aplicables. Por tanto, esta Ley no tiene el propósito de duplicar permisos, autorizaciones, reportes ni cargas administrativas sobre dichas farmacias residentes.

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

1 Sección 1.- Se enmienda el Artículo 1.02 de la Ley 247-2004, según enmendada,
2 conocida como “Ley de Farmacia de Puerto Rico”, para que lea como sigue:

3 “Artículo 1.02. — Propósito.

4 El propósito de esta Ley es promover, preservar y proteger la salud, la
5 seguridad y el bienestar público mediante el control y reglamentación efectivo de la
6 práctica de farmacia no residente y el licenciamiento, control y reglamentación de los
7 establecimientos y personas que manufacturan, distribuyen, dispensan y expenden
8 medicamentos y artefactos que se utilizan en el diagnóstico, tratamiento y prevención
9 de enfermedades a pacientes localizados en Puerto Rico, independientemente del
10 lugar físico donde se origine el despacho.”

11 Sección 2. - Se añaden los nuevos incisos (k-1), (u-1), (u-2), (aa-1), (dd-1) (dd-2)
12 y (nn-1) al Artículo 1.03 de la Ley 247-2004, según enmendada, conocida como “Ley
13 de Farmacia de Puerto Rico”, para que lea como sigue:

14 “Artículo 1.03. — Definiciones.

1 A los fines de esta Ley, los siguientes términos y frases tendrán el significado
2 que a continuación se indica:

3 (a) ...

4 ...

5 (k) ...

6 (k-1) Dispensación a paciente localizado en Puerto Rico - La dispensación o
7 despacho que se realiza por una farmacia no residente a un paciente, prescribiente
8 cuya dirección de entrega se encuentra en Puerto Rico.

9 (l) ...

10 ...

11 (u) ...

12 (u-1) Evento Adverso - Cualquier acontecimiento médico desfavorable que
13 ocurra durante o después del uso de un medicamento y respecto del cual exista una
14 sospecha razonable de asociación con dicho medicamento, independientemente de
15 que dicha relación causal haya sido confirmada.

16 (u-2) Evento Adverso Grave - Un evento adverso que resulte en cualquiera de
17 los siguientes resultados: muerte, una experiencia que ponga en peligro la vida,
18 hospitalización de un paciente; una incapacidad o discapacidad persistente o
19 significativa, una anomalía congénita o defecto de nacimiento, o un evento que
20 requiera, según el juicio médico razonable, una intervención médica o quirúrgica para
21 prevenir alguno de los resultados antes descritos.

22 (v) ...

1 (aa) ...

2 (aa-1) Farmacia no residente – Establecimiento de servicio de salud dedicados
3 a la prestación de servicios farmacéuticos, que incluye: la dispensación de
4 medicamentos de receta, medicamentos sin receta, artefactos y otros productos
5 relacionados con la salud, la prestación de cuidado farmacéutico y otros servicios
6 dentro de las funciones del farmacéutico establecidas en esta Ley, incluyendo a
7 instalaciones 503A, localizadas fuera de Puerto Rico que ejerza dispensación a paciente
8 localizado en Puerto Rico por correo, mensajería, telemedicina o cualquier otro
9 método remoto.

10 (bb) ...

11 ...

12 (dd) ...

13 (dd-1) Ingrediente farmacéutico activo - Toda sustancia destinada a
14 incorporarse en un medicamento terminado y que tenga por objeto proporcionar
15 actividad farmacológica u otro efecto directo en el diagnóstico, cura, mitigación,
16 tratamiento o prevención de enfermedades, o afectar la estructura o cualquier función
17 del organismo humano. El término no incluirá los intermediarios utilizados en la
18 síntesis de dicha sustancia ni los ingredientes inactivos del medicamento, tales como
19 agentes saborizantes o excipientes.

20 (dd-2) Facilidad que fabrica un ingrediente farmacéutico activo - el
21 establecimiento donde se creó originalmente un ingrediente farmacéutico activo

1 mediante procedimientos o manipulaciones químicas, físicas, biológicas o de otro tipo.

2 No incluye a las droguerías ni los distribuidores al por mayor de medicamentos.

3 (ee) ...

4 ...

5 (nn) ...

6 (nn-1) Medicamento compuesto de alto riesgo –Medicamento compuesto que,
7 según el reglamento adoptado por el Departamento de Salud con participación de la
8 Junta Examinadora de Farmacia y oportunidad de comentario público, presente riesgo
9 significativo documentado por razón de esterilidad, vía de administración,
10 complejidad de preparación, historial de eventos adversos, margen terapéutico
11 estrecho o ausencia de controles adecuados de trazabilidad.

12 Ningún medicamento será clasificado como medicamento compuesto de alto
13 riesgo salvo que exista evidencia científica documentada de un riesgo significativo
14 para la salud pública, sustentada por informes de la Food and Drug Administration
15 (FDA).

16 No se considerará automáticamente de alto riesgo toda preparación estéril por
17 el solo hecho de ser estéril. La determinación deberá basarse en criterios técnicos y
18 evidencia documentada.

19 No se considerará “Medicamento Compuesto de Alto Riesgo” la preparación
20 estéril realizada dentro de un hospital debidamente licenciado en Puerto Rico, cuando:
21 sea realizada por una farmacia institucional bajo la supervisión de un farmacéutico
22 licenciado; se administre exclusivamente a un paciente admitido o registrado; y

1 responda a una orden médica válida, receta o protocolo terapéutico institucional. Esta
2 exclusión aplicará únicamente a hospitales y no incluirá spas médicos, clínicas de
3 bienestar, prácticas estéticas, clínicas ambulatorias comerciales, consultorios no
4 institucionales ni establecimientos análogos, independientemente de su
5 licenciamiento.

6 (oo) ...

7 ...

8 (mmm) ...”

9 Sección 3. - Se añade un nuevo inciso (f) al Artículo 5.04 de la Ley 247-2004,
10 según enmendada, conocida como “Ley de Farmacia de Puerto Rico”, para que lea
11 como sigue:

12 “Artículo 5.04. — Medicamentos con requisitos especiales para su
13 dispensación.

14 (a) ...

15 ...

16 (e) ...

17 (f) Medicamento compuesto de alto riesgo

18 (i) Para la composición y dispensación de medicamentos compuestos de
19 alto riesgo, las farmacias no residentes deberán solicitar y obtener del
20 Secretario una autorización especial para la dispensación de tales
21 medicamentos conforme a los requisitos que se establezcan mediante
22 reglamento. Ninguna farmacia no residente, podrá dispensar

1 medicamentos compuestos de alto riesgo sin contar con dicha
2 autorización especial vigente.

3 (ii) Toda farmacia no residente que obtenga la autorización del
4 Secretario para la dispensación de medicamentos compuestos de alto
5 riesgo, al momento de su solicitud inicial y en cada renovación, deberá
6 presentar ante el Secretario, o la secretaría, división o junta que este
7 designe, una declaración de divulgación de la actividad de composición
8 farmacéutica ("compounding") de medicamentos compuestos
9 preparados y dispensados por dicha farmacia no residente a pacientes
10 localizados en Puerto Rico que debe al menos incluir:

- 11 1. Las categorías de medicamentos compuestos preparados,
12 incluyendo si son estériles o no estériles;
- 13 2. La cantidad total de unidades de medicamentos compuestos
14 preparadas durante el período de licencia anterior, clasificadas en
15 preparaciones estériles y no estériles;
- 16 3. Una descripción de si los medicamentos compuestos se
17 dispensan para administración en la farmacia, en un consultorio
18 médico, dispensación directa al paciente o distribución a otras
19 facilidades;
- 20 4. El número de pacientes atendidos con medicamentos
21 compuestos durante el período del informe;

1 5. Cualquier información adicional que la normativa exija
2 razonablemente para evaluar la escala y el perfil de riesgo de las
3 actividades de preparación de medicamentos compuestos.

4 6. Toda farmacia no residente deberá incluir en su declaración
5 de divulgación de la actividad de composición farmacéutica
6 (“compounding”) de medicamentos compuestos preparados y
7 dispensados a pacientes localizados en Puerto Rico:

8 a) Una copia del informe más reciente de inspección del
9 estado donde está físicamente operando; y

10 b) Una descripción de cualquier acción disciplinaria
11 impuesta por cualquier organismo regulador en contra de
12 dicha farmacia no residente.

13 (iii) Independientemente de la obtención de una autorización especial
14 para la dispensación de medicamentos compuestos de alto riesgo, se
15 prohíbe:

16 1. El envío directo a spas médicos, clínicas estéticas, centros de
17 bienestar o establecimientos no institucionales no autorizados por
18 la Secretaría Auxiliar para la Regulación de la Salud Pública
19 (SARSP) del Departamento de Salud de Puerto Rico;

20 2. La dispensación basada en protocolos estandarizados sin
21 evaluación clínica individualizada;

(iv) Todo medicamento compuesto de alto riesgo deberá entregarse acompañado de:

1. nombre y dirección de la farmacia preparadora;
2. nombre del farmacéutico responsable;
3. número de lote o identificación de preparación;
4. fecha de preparación y fecha de expiración clínica;
5. advertencia visible indicando que el producto es un medicamento compuesto no aprobado por la Food and Drug Administration (FDA);
6. Información de contacto para reportar eventos adversos; y
7. Rotulación adecuada en cumplimiento con el Artículo 5.02 (d) de esta Ley.

(v) Las farmacias no residentes solo podrán vender, transferir o distribuir medicamentos compuestos de alto riesgo si se cumplen los siguientes requisitos:

1. El ingrediente farmacéutico activo cumple con la Sección 503A(b)(1)(A) de la Ley Federal de Alimentos, Medicamentos y Cosméticos (21 U.S.C. § 353a(b)(1)(A));
2. El ingrediente farmacéutico activo es un producto de grado farmacéutico para uso humano;
3. El ingrediente farmacéutico activo está acompañada de una certificación válida que contenga la identidad, pureza y potencia

del ingrediente farmacéutico activo, así como cualquier información adicional que requiera el Secretario;

4. Todo ingrediente farmacéutico activo que no esté descrito en la Farmacopea de los Estados Unidos (United States Pharmacopeia) o del Formulario Nacional (National Formulary):

a. estará acompañado de documentación de pruebas adecuadas de control de calidad realizadas por la facilidad que fabrica un ingrediente farmacéutico activo, un fabricante subsiguiente o un distribuidor al por mayor, que:

i. confirmen la identidad y el contenido del ingrediente farmacéutico activo;

ii. informen, identifiquen, caractericen y cuantifiquen cada impureza y solvente residual presente en el ingrediente farmacéutico activo en una cantidad que exceda una décima de uno por ciento (0.1%); y

iii. contengan cualquier información adicional que pueda requerir el Secretario; o

b. antes de utilizar el ingrediente farmacéutico activo en la preparación del medicamento compuesto de alto riesgo, la persona dedicada a la preparación deberá obtener pruebas

1 adecuadas de control de calidad que contengan la
2 información especificada en el Artículo 5.04(f)(vi)(4)(a)(i)-
3 (iii). La información de control de calidad requerida por
4 este Artículo 5.04(f)(vi)(5) podrá incluirse en la
5 certificación descrita en el Artículo 5.04(f)(vi)(3).

6 (vii)(a) Toda farmacia no residente deberá mantener documentación
7 verificable de que el ingrediente farmacéutico activo fue fabricado en
8 una facilidad que fabrica un ingrediente farmacéutico activo que:

- 9 1. está debidamente registrado ante la Food and Drug
10 Administration (FDA) bajo la Sección 510 del Food, Drug and
11 Cosmetic Act (21 U.S.C. 360);
- 12 2. ha sido sometido a una inspección por parte de la Food and
13 Drug Administration (FDA) como establecimiento de
14 medicamentos para uso humano;
- 15 3. no está actualmente sujeto a una inspección no resuelta por
16 parte de la Food and Drug Administration (FDA) que fue
17 clasificada como “Acción Oficial Indicada” (“Official Action
18 Indicated”);
- 19 4. actualmente no está sujeto a ninguna Alerta de Importación
20 emitida por la Food and Drug Administration (FDA); y
- 21 5. no está actualmente sujeto a una Carta de Advertencia no
22 resuelta de la Food and Drug Administration (FDA).

1 La documentación requerida por este párrafo también debe incluir: País
2 de origen, dirección y número de identificación de establecimiento de la
3 Food and Drug Administration (FDA) de la Facilidad que fabrica un
4 ingrediente farmacéutico activo.

5 (b) Es ilegal que cualquier fabricante o mayorista venda, transfiera o
6 distribuya un ingrediente farmacéutico activo para su uso en la
7 preparación de compuestos sin proporcionar al comprador la
8 certificación requerida en el Artículo 5.04(f)(vi)(3), la documentación de
9 pruebas de control de calidad y la verificación escrita descrita en el
10 Artículo 5.04(f)(vi)(3) al Artículo 5.04(f)(vi)(4) y el Artículo
11 5.04(f)(viii)(a).

12 (viii) La preparación de medicamentos compuestos de alto riesgo deberá
13 cumplir con el Federal Food, Drug and Cosmetic Act, incluyendo las
14 disposiciones de la Sección 503A (21 U.S.C. 353a).

15 (ix) (a) Las farmacias no residentes que se dedican a la venta,
16 transferencia o distribución de medicamentos compuestos de alto riesgo
17 deberán mantener todos los registros relacionados con la adquisición, el
18 examen y la prueba del ingrediente farmacéutico activo durante no
19 menos de dos (2) años después de la fecha de vencimiento del último
20 lote de medicamento compuesto de alto riesgo que contenga el
21 ingrediente farmacéutico activo y, a solicitud del Secretario, deberán

1 proporcionar dichos registros dentro de un tiempo razonable según lo
2 determine el Secretario en función de las circunstancias de la solicitud.

3 (b) El Secretario o la secretaría, división o junta que este designe, tendrá
4 la facultad de requerir a cualquier farmacia no residente que venda,
5 transfiera o distribuya medicamentos compuestos de alto riesgo, así
6 como cualquier Facilidad que fabrique un ingrediente farmacéutico
7 activo, fabricante posterior o Distribuidor al por mayor de
8 medicamentos que venda, transfiera o distribuya un ingrediente
9 farmacéutico activo para su uso en la preparación de compuestos, la
10 documentación, certificaciones, autorizaciones o licencias necesarias
11 para verificar el cumplimiento con los requisitos del Artículo 5.04(f)(v)
12 al Artículo 5.04(f)(viii). Negarse a proveer documentación requerida por
13 el Secretario o la secretaría, división o junta que este designe para
14 verificar el cumplimiento con los requisitos del Artículo 5.04(f)(v) al
15 Artículo 5.04(f)(viii) constituirá una violación a esta Ley.

16 (c) El Secretario está autorizado a promulgar las reglas que sean
17 necesarias para implementar esta Ley.

18 (x)(a) Las violaciones del Artículo 5.04(f)(vi), 5.04(f)(vii) y 5.04(f)(viii) darán
19 lugar a:

20 1. una multa de mil dólares (\$1,000) por cada dosis del medicamento
21 compuesto de alto riesgo vendida, transferida o distribuida; y

1 2. revocación de la licencia de Distribuidor al por mayor de
2 medicamentos o de Droguería y cualquier otra licencia, certificado,
3 registro o autorización emitida por el Secretario de Salud.

4 (b) Las violaciones del Artículo 5.04(f)(vii)(b) de esta Ley darán lugar a:

- 5 1. una multa de mil dólares (\$1,000) por cada miligramo del ingrediente
6 farmacéutico activo distribuido ilegalmente; y
7 2. revocación de la licencia de Distribuidor al por mayor de
8 medicamentos o de Droguería.

9 (c) Las violaciones del Artículo 5.04(f)(ix) resultarán en una multa de \$5,000
10 y darán lugar a la revocación de la licencia correspondiente.

11 (xi) Todo farmacéutico que conozca de un evento adverso asociado a un
12 medicamento compuesto de alto riesgo dispensado o administrado a un
13 paciente localizado en Puerto Rico deberá notificarlo al Departamento de
14 Salud dentro de diez (10) días laborables desde que advenga en
15 conocimiento, en caso de un evento adverso grave, deberá notificarlo al
16 Departamento de Salud dentro de cinco (5) días laborables desde que
17 advenga en conocimiento.”

18 Sección 4.- Se añade un nuevo Artículo 5.11-A a la Ley 247-2004, según
19 enmendada, conocida como “Ley de Farmacia de Puerto Rico”, para que lea como
20 sigue:

21 “Artículo 5.11. — Farmacia.

1 (a)...

2 ...

3 (i) ...

4 Artículo 5.11-A. – Farmacia no residente con dispensación a paciente localizado
5 en Puerto Rico.

6 (a) Ninguna farmacia no residente podrá dispensar, enviar, entregar, causar la
7 entrega, facturar o de cualquier forma proveer medicamentos a pacientes localizados
8 en Puerto Rico sin previamente registrarse ante la Secretaría Auxiliar para la
9 Regulación de la Salud Pública (SARSP) del Departamento de Salud de Puerto Rico
10 como farmacia no residente y recibir un certificado de registro de farmacia no
11 residente.

12 (b) Para configurar un registro válido y obtener un certificado de registro de
13 farmacia no residente la farmacia no residente deberá presentar:

14 1. Una licencia vigente y en buen estado en la jurisdicción donde ubique
15 físicamente;

16 2. Aprobación del National Association of Boards of Pharmacy Digital
17 Pharmacy Accreditation Program;

18 3. Identificar un representante de cumplimiento regulatorio para
19 pacientes localizados en Puerto Rico, quien fungirá como punto de
20 contacto principal ante el Departamento de Salud y responderá ante
21 cualquier evento de incumplimiento con esta Ley. Un representante no
22 podrá ser designado responsable para más de una farmacia no residente;

1 4. Designar un agente representante en Puerto Rico autorizado a recibir
2 notificaciones administrativas y judiciales;

3 5. Presentar una declaración jurada certificando y haciendo constar que
4 una vez registrada la farmacia no residente cumplirá con:

5 (i) someter certificaciones de cumplimiento con estándares
6 aplicables de preparación y manejo de medicamentos;

7 (ii) Mantener y proveer, a requerimiento del Departamento de
8 Salud de Puerto Rico documentación verificable relacionada con
9 recetas, preparación, dispensación y envío de medicamentos a
10 pacientes localizados en Puerto Rico;

11 (iii) Notificar al Departamento de Salud de Puerto Rico cualquier
12 evento adverso con medicamentos dispensados o administrados
13 a pacientes localizados en Puerto Rico dentro de un término no
14 mayor de diez (10) días laborables o en casos de evento adverso
15 grave en cinco (5) días laborables contados en ambas instancias
16 desde que advenga en conocimiento o razonablemente debió
17 haber conocido de dicho evento;

18 (iv) Cumplir con los requisitos de reporte establecidos en esta
19 Ley.

20 6. Sufragar los derechos establecidos en el Artículo 5.16 de esta Ley.

21 (c) Requisitos de Reporte. Toda farmacia no residente registrada ante la

22 Secretaría Auxiliar para la Regulación de la Salud Pública (SARSP) del Departamento

1 de Salud de Puerto Rico, que a su vez haya obtenido la autorización de medicamentos
2 compuestos de alto riesgo, deberá al momento del registro y renovación presentar una
3 declaración de divulgación de la actividad de composición farmacéutica
4 (“compounding”) de medicamentos compuestos preparados y dispensados a
5 pacientes localizados en Puerto Rico de conformidad con el Artículo 5.04(f) de esta
6 Ley.

7 (d) Al cumplir con los parámetros de este Artículo, la Secretaría Auxiliar para
8 la Regulación de la Salud Pública (SARSP) emitirá un Certificado de Registro de
9 farmacia no residente. El Certificado de Registro de farmacia no residente será válido
10 por un (1) año. El mismo debe ser renovado anualmente mediante presentación de los
11 documentos requeridos en este Artículo al menos cuarenta y cinco (45) días antes de
12 su vencimiento.

13 (e) Ningún plan médico, aseguradora, administrador de beneficios de farmacia
14 (PBM), hospital, clínica, farmacia o proveedor de salud establecido en Puerto Rico y
15 regulado por las leyes y reglamentos del Gobierno de Puerto Rico podrá pagar,
16 procesar, adjudicar o reembolsar reclamaciones por medicamentos dispensados a
17 pacientes localizados en Puerto Rico por farmacias no residentes no registradas
18 conforme a esta Ley.

19 (f) Ningún profesional de la salud autorizado a ejercer en Puerto Rico y sujeto
20 a las leyes y reglamentos del Gobierno de Puerto Rico podrá ordenar, coordinar la
21 dispensación ni administrar medicamentos a través de una farmacia no residente no
22 registrada.

1 (g) El Secretario, en coordinación o por vía de la Secretaría Auxiliar para la
2 Regulación de la Salud Pública (SARSP), está facultado para:

- 3 1. Emitir órdenes administrativas de cese y desista respecto a la
4 dispensación de medicamentos hacia pacientes localizados en Puerto
5 Rico;
- 6 2. notificar a agencias regulatorias estatales o federales;
- 7 3. requerir a planes médicos o PBMs la denegación de reclamaciones
8 provenientes de farmacias no residente son registradas; y
- 9 4. establecer multas administrativas conforme a la Ley 38-2017, según
10 enmendada, conocida como “Ley de Procedimiento Administrativo
11 Uniforme del Gobierno de Puerto Rico”.

12 (h) El Secretario, en coordinación o por vía de la Secretaría Auxiliar para la
13 Regulación de la Salud Pública (SARSP), deberá:

- 14 1. Aprobar los reglamentos que sean necesarios para hacer cumplir lo
15 dispuesto en este Artículo.
- 16 2. Publicar el registro de farmacias no residentes.

17 (i) Nada en este Artículo autoriza a la Secretaría Auxiliar para la Regulación de
18 la Salud Pública (SARSP) ni al Departamento de Salud de Puerto Rico a regular las
19 operaciones internas de farmacias no residentes. La autoridad conferida se limita
20 exclusivamente a la protección de la salud pública respecto a la dispensación y
21 administración de medicamentos a pacientes localizados en Puerto Rico.

1 (j) Este Artículo se interpretará como una medida de salud pública dirigida
2 exclusivamente a regular la dispensación de medicamentos a pacientes localizados en
3 Puerto Rico y no como una regulación extraterritorial del ejercicio de la profesión de
4 la farmacia fuera de Puerto Rico.”

5 Sección 5.- Se enmienda el Artículo 5.16 de la Ley 247-2004, según enmendada,
6 conocida como “Ley de Farmacia de Puerto Rico”, para que lea como sigue:

7 “Artículo 5.16. — Vigencia y derechos de licencias, certificados, registros y
8 autorizaciones.

9 (a) Las licencias y registros requeridas en este Capítulo, salvo lo relacionado al
10 Registro de Medicamentos y al Certificado de Registro de Farmacia No Residente,
11 tendrán dos (2) años de vigencia desde la fecha de su expedición y se renovarán en
12 forma escalonada, previo el cumplimiento de los requisitos y procedimientos que se
13 establezcan por reglamento y el pago de los correspondientes derechos; con excepción
14 de los certificados de registros de medicamentos y/o productos biológicos para
15 oficinas médicas, dentales y podiátricas, y para ensayos clínicos en instituciones de
16 educación superior u oficinas médicas, que tendrán tres (3) años de vigencia, y se
17 obtendrán mediante radicación del registro según la fecha de renovación de licencia
18 profesional del médico, dentista o podiatra, cuando corresponda. Además, será deber
19 del Departamento de Salud, en lo posible y mientras los recursos fiscales lo permitan,
20 el establecer los procedimientos para poder radicar y expedir mediante su página
21 electrónica gubernamental (Internet) la solicitud para obtener las licencias requeridas

1 en este Capítulo o el Certificado de Registro Trienal de Medicamentos y/o Productos
2 Biológicos en Oficina Médica, y Certificado de Registro Trienal de Medicamentos y/o
3 Biológicos para Ensayos Clínicos en Institución de Educación Superior y el certificado
4 de registro de farmacia no residente.

5 (b) ...

6 (c) Toda persona que opere más de un establecimiento de los definidos en esta
7 Ley, deberá solicitar y obtener una licencia, certificado, registro o autorización
8 separada para cada uno de los establecimientos.

9 (d) Las licencias, certificados, registros y autorizaciones no serán transferibles.

10 (e) La licencia, certificado, registro o autorización se expedirá a nombre del
11 dueño o razón comercial que la solicite y aplicará solamente al establecimiento en la
12 localización que se indique en la faz de la misma. Además, especificará el tipo de
13 establecimiento para el cual se otorga según definidos en esta Ley.

14 (f) Las licencias, certificados, registros y autorizaciones que se enumeran a
15 continuación pagarán los siguientes derechos que estarán vigentes desde la fecha de
16 aprobación de esta Ley hasta que el Secretario, mediante reglamento, establezca otros
17 derechos:

18 1. ...

19 ...

20 17...

21 18. Certificado de Registro de farmacia no residente - \$500.

1 (g) ...

2 (h) Los ingresos que se recauden por estos conceptos serán depositados en el
3 Fondo de Salud creado bajo las disposiciones del Artículo 11-A de la Ley Núm. 26 de
4 13 de noviembre de 1975, según enmendada, para uso exclusivo de la División de
5 Farmacia, en la fiscalización del cumplimiento de las disposiciones en el Capítulo V
6 de esta Ley; con excepción de los fondos que se recauden del Certificado de Registro
7 de Farmacia no residente. Los recaudos del Certificado de Registro de Farmacia no
8 residente deberán ser transferidos al Departamento de Salud para fortalecer las
9 capacidades de la Secretaría Auxiliar para la Regulación de la Salud Pública (SARSP)."

10 Sección 6.- Se añade un nuevo Artículo 5.18 a la Ley 247-2004, según
11 enmendada, conocida como "Ley de Farmacia de Puerto Rico", para que lea como
12 sigue:

13 Artículo 5.18. – Informe sobre Supervisión de la Preparación de Medicamentos
14 Compuestos.

15 La Secretaría Auxiliar para la Regulación de la Salud Pública (SARSP) junto con
16 la Oficina de Planificación y Desarrollo, o cualquier otra secretaría, unidad, oficina o
17 dependencia que el Secretario del Departamento de Salud determine, desarrollará y
18 publicará un informe bianual sobre la supervisión de la preparación de medicamentos
19 y los riesgos compuestos asociados con dichas prácticas. Dicho informe incluirá los
20 siguientes elementos:

1 (a) El número de certificaciones a farmacias no residentes emitidas por el
2 Secretario, o la secretaría, división o junta que este designe, para la dispensación
3 de medicamentos compuestos de alto riesgo, incluyendo autorizaciones para la
4 dispensación de medicamentos estériles para uso parenteral o cualesquiera
5 otros medicamentos que requieran técnicas asépticas especiales.

6 (b) El número de certificados de registro de farmacias no residentes emitidos
7 por la Secretaría Auxiliar para la Regulación de la Salud Pública (SARSP).

8 (c) El número de instalaciones y prácticas licenciadas, autorizadas o registradas
9 que han sido inspeccionadas en el último año y en los últimos tres años,
10 desglosado por tipo de licencia, autorización o registro.

11 (d) El número de inspecciones realizadas a instalaciones y prácticas
12 involucradas en la preparación de medicamentos compuestos de alto riesgo, o
13 en el manejo, almacenamiento, administración, dispensación, distribución u
14 otro uso de medicamentos preparados en el ámbito minorista o ambulatorio,
15 incluyendo farmacias no residentes, pero excluyendo instalaciones de salud
16 licenciadas como hospitales o centros quirúrgicos ambulatorios.

17 (e) Una descripción de la naturaleza y gravedad de cualquier deficiencia o
18 posible violación observada durante las inspecciones o reportadas por
19 farmacéuticos.

1 (f) El número de investigaciones abiertas por el Departamento de Salud, o
2 cualquier otra agencia estatal a la que se le haya referido una investigación,
3 relacionadas con la preparación de medicamentos.

4 (g) El número y tipo de acciones disciplinarias tomadas por el Departamento
5 de Salud, o cualquier otra agencia estatal a la que se le haya referido una
6 investigación, relacionadas con la preparación de medicamentos compuestos.

7 (h) Una evaluación de los recursos humanos y materiales de la Secretaría
8 Auxiliar para la Regulación de la Salud Pública (SARSP), en relación con la
9 escala estimada de la preparación de medicamentos compuestos de alto riesgo.

10 (i) Un análisis de la naturaleza y gravedad de los riesgos emergentes
11 relacionados con la preparación de medicamentos compuestos de alto riesgo, y
12 la distribución, comercialización y venta de medicamentos compuestos.

13 El primer informe se publicará a más tardar el 30 de septiembre de 2027, con
14 datos correspondientes del 1 de enero de 2027 al 30 de junio de 2027. Posteriormente,
15 los informes se publicarán dos veces al año, a más tardar el 1 de marzo y el 1 de
16 septiembre de cada año, conteniendo datos de los seis meses anteriores,
17 respectivamente. Los informes no contendrán información protegida por la Health
18 Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA).

19 Los informes bianuales serán publicados en la página electrónica oficial de la
20 Secretaría Auxiliar para la Regulación de la Salud Pública (SARSP) o del
21 Departamento de Salud de Puerto Rico, además de estar disponibles para consulta

1 pública sin costo alguno. La Secretaría Auxiliar para la Regulación de la Salud Pública
2 (SARSP) notificará al público sobre la publicación de cada informe mediante
3 comunicados oficiales.

4 Se prohíbe imponer cualquier cargo monetario a los ciudadanos, profesionales
5 de la salud o instalaciones licenciadas para el cumplimiento de la divulgación del
6 informe bianual establecido en esta Sección.

7 Sección 7.- Farmacias localizadas físicamente en la jurisdicción de Puerto Rico.

8 Nada de lo dispuesto en estas enmiendas, se interpretará como una limitación,
9 sustitución, duplicación o ampliación de los requisitos aplicables a farmacias
10 localizadas físicamente en la jurisdicción de Puerto Rico, debidamente licenciadas bajo
11 la Ley 247-2004. Estas farmacias, incluyendo las farmacias 503A que realicen
12 composición farmacéutica estéril o no estéril, continuarán reguladas por la “Ley de
13 Farmacia de Puerto Rico”, sus reglamentos, la Junta Examinadora de Farmacia, el
14 Departamento de Salud y los estándares de USP aplicables.

15 Sección 8.- Reglamentación.

16 El Secretario del Departamento de Salud está autorizado y deberá, dentro de
17 ciento ochenta (180) días de aprobada esta Ley, aprobar o enmendar los reglamentos
18 que sean necesarios para el fiel cumplimiento de esta Ley.

19 Sección 9.- Cláusula de separabilidad.

20 Si alguna de las disposiciones de esta Ley o su aplicación fuere declarada
21 inconstitucional o nula, tal dictamen de invalidez o nulidad no afectará la

- 1 ejecutabilidad y vigor de las restantes disposiciones que no hayan sido objeto de
- 2 dictamen adverso.

3 Sección 10.- Vigencia.

4 Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.